

당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다

당뇨병 첫 외래 안내 — 진단의 의미부터 오늘 하는 검사, 우리가 함께 할 일까지

진단 직후가 가장 중요합니다 — 지금 시작하면 평생이 달라집니다

당화혈색소(HbA1c, 지난 2~3개월 평균 혈당)를 1%만 낮춰도 눈·신장·신경 합병증이 크게
줄어듭니다 — 첫 1~2년 관리가 평생을 좌우

37%

오늘의 메시지

당뇨병은 그 자체보다 합병증이 두려운 병입니다. 그러나 합병증은
예방 가능합니다. 진단은 끝이 아니라 관리의 시작점이며, 가장
효과가 큰 시점이 바로 지금입니다. 약·식사·운동·검사 네 가지를
함께 맞춰가면 합병증 없이 평생 지낼 수 있습니다.

HbA1c 1% 감소 시 미세혈관 합병증(눈·신장·신경) 위험 감소
— 진단 초기의 좋은 조절은 시간이 지나도 효과가 남는다는 연구
결과가 있습니다.

당뇨병 진단이 의미하는 것

혈당을 낮추는 인슐린이 잘 듣지 않고(저항성), 만드는 양도 줄어든 상태 — 둘 다 관리할 수 있습니다



혈당이 만성적으로 높아진 상태 — 핵심은 인슐린 저항성과 인슐린 분비 감소가 함께 일어난다는 점입니다.

내장지방이 늘면 간·근육·지방이 인슐린에 둔감해집니다(저항성). 췌장은 이를 메우려 인슐린을 더 짜내다 점차 지칩니다. 그래서 당뇨병은 "의지가 약해서" 생기는 병이 아니라 **체질·유전·생활이 겹친 대사질환**입니다. 다행히 두 기전 모두 약과 생활습관으로 되돌리거나 늦출 수 있습니다.

인슐린 저항성

간·근육·지방

체중 감소·운동으로 가장 잘 개선되는 부분입니다.

베타세포 기능

진단 시 ≈ 50%

조기에 부담을 덜어주면 남은 기능을 오래 지킬 수 있습니다.

오늘 첫 외래에서 하는 검사 — 출발점을 확인합니다

지금의 혈당 수준과 이미 시작된 합병증이 있는지 한 번에 점검합니다 (일부는 채혈·예약으로 진행)

검사 · 01

혈당 · 당화혈색소(HbA1c)



공복혈당 + 최근 2~3개월 평균인 HbA1c로 현재 조절 수준과 첫 목표치를 정합니다.

검사 · 02

혈압 · 지질(콜레스테롤)



당뇨는 혈관병입니다. 혈압·나쁜 콜레스테롤(LDL)을 함께 관리해야 심근경색·뇌졸중을 막습니다.

검사 · 03

신장 — 소변알부민 · eGFR



콩팥 합병증은 초기에 증상이 없습니다. 소변검사(uACR, 소변 속 단백)와 혈액검사(eGFR, 콩팥 거르는 기능)로 가장 먼저 신호를 잡습니다.

검사 · 04

눈(안저) · 발 검진



진단 시 안저검사 1회 + 발 감각·맥박 확인. 망막·신경 합병증 조기 발견용입니다.

함께 관리할 4가지 축 — 혼자 하지 않습니다

네 가지가 서로 맞물려야 혈당이 안정됩니다. 한 번에 다 바꾸지 않고 하나씩 같이 만들어갑니다

PILLAR · 01

식사 — 점시법



1/2 채소, 1/4 단백질, 1/4 통곡물. 굵지 않고 균형을 맞추는 것이 핵심입니다.



PILLAR · 02

운동 — 주 150분



빠르게 걷기 등 중강도 유산소 + 주 2회 근력. 식후 10분 걷기부터 시작합니다.



PILLAR · 03

약물 — 부담 없이 시작

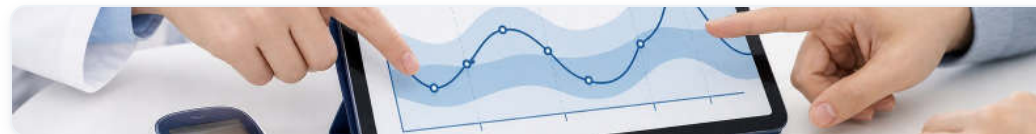


대부분 메트포민으로 시작합니다. 동반질환이 있으면 장기 보호 약도 함께 정합니다.



PILLAR · 04

자가측정 — 내 패턴 알기



음식·운동·약의 효과를 기록으로 확인합니다. 다음 진료 때 흐름을 함께 봅니다.



약물의 시작 — 메트포민, 걱정보다 안전합니다

40년 이상 검증된 1차 약. 저혈당·체중 증가가 거의 없고, 서서히 늘려 부작용을 줄입니다



메트포민(Metformin)은 간에서 당이 과하게 만들어지는 것을 줄이고 인슐린 감수성을 높이는 모든 환자의 1차 약물입니다.

500mg 1회로 시작해 1~2주마다 천천히 늘립니다. 속이 불편할 수 있어 **식사와 함께** 복용하고 서서히 증량하면 대부분 적응합니다. 임의로 끊지 말고, 속쓰림·설사가 심하면 줄이거나 천천히 녹는 형태(서방형)로 바꿀 수 있으니 알려주세요. 콩팥 기능이 많이 떨어졌거나(eGFR 30 미만) 조영제 검사 전후에는 잠시 중단합니다.

HBA1C 감소

1.0 ~ 1.5 %

체중 중립 · 저혈당 거의 없음.

동반질환 시

심장·콩팥 보호약

심장·콩팥을 함께 보호하는 비교적 새로운 당뇨약(SGLT2 억제제·GLP-1 계열)을 처음부터 같이 쓰기도 합니다.

식사 — 무엇을 더하고 무엇을 줄일까

완벽한 식단이 아니라 매 끼의 작은 선택이 쌓입니다 — 진단 직후부터 시작하면 가장 효과적

+ 🍴 늘리기 — 혈당을 안정시키는 선택

- + 접시법 — ½ 채소, ¼ 단백질, ¼ 통곡물
- + 채소 먼저 먹기 — 식후 혈당 상승 완화
- + 식이섬유 25g/일 — 채소·통곡물·콩
- + 물·무가당 음료로 갈증 해결
- + 일정한 식사 시간 — 거르지 않기
- + 식후 10분 걷기 — 가장 쉬운 혈당 관리

— 🍷 줄이기 — 혈당을 급등시키는 선택

- 정제 탄수화물 — 흰밥·흰빵·국수 과다
- 가당 음료·주스 — 콜라·믹스커피
- 야식·폭식 — 식후 혈당 급등
- 국물·젓갈 과다 — 혈압까지 악화
- 과음 — 저혈당·간 부담
- 과일주스·말린 과일 — 농축된 당 주의

나의 첫 목표치 — 숫자로 함께 확인합니다

목표는 사람마다 다릅니다. 나이·동반질환·저혈당 위험을 고려해 함께 조정합니다 (일반 성인 기준)

TARGET · 01

당화혈색소 HbA1c — 대부분 6.5% 이하



나이가 많거나 저혈당 위험이 크면 7~8%로 함께 조정합니다. 내 목표치는 진료 때 정합니다.

TARGET · 02

공복혈당 80 ~ 130 · 식후 < 180



매 끼니가 아니라 평균과 패턴이 중요합니다. 자가측정으로 흐름을 봅니다.

TARGET · 03

혈압 < 130/80 mmHg



당뇨 환자는 대부분 130/80 미만이 목표입니다(위험인자 없으면 다소 완화). 가정혈압을 같은 시간에 재 보세요.

TARGET · 04

LDL 콜레스테롤 < 100 (고위험 < 70)



혈관 보호를 위해 스타틴을 함께 쓰는 경우가 많습니다. 목표는 위험도에 따라 정합니다.

앞으로의 일정 — 함께 가는 길

오늘이 끝이 아닙니다. 아래 흐름으로 함께 점검하며 약과 목표치를 맞춰갑니다 (개인별로 조정)

STEP · 01 · 오늘

첫 평가 · 약 시작



기본 검사로 출발점 확인 + 메트포민 시작 + 자가측정 방법 안내. 궁금증은 무엇이든 물어보세요.

STEP · 02 · 1~2주 후

약 적응 · 증량 점검



속이 불편하지 않은지 확인하고 필요하면 용량을 올립니다. 자가측정 기록을 함께 봅니다.

STEP · 03 · 약 3개월 후

HbA1c 재검 · 목표 확인



첫 목표 달성 여부를 확인하고 약·생활을 조정합니다. 안정되면 6개월 간격으로 늘립니다.

STEP · 04 · 이후 정기

합병증 정기 검진



연 1회 안저·신장(소변·혈액)·발 검진으로 합병증을 조기에 잡습니다. 예방접종도 함께 챙깁니다.

이럴 땐 바로 연락 또는 내원하세요

초기에는 드물지만, 아래 신호는 급성 합병증의 경고입니다 — 망설이지 말고 알려주세요

URGENT · 01

저혈당 (혈당 < 70)



식은땀·떨림·어지러움이 오면 바로 당분 섭취 — 주스 반 컵·사탕 3~4개·설탕 1큰술(약 15g). 15분 뒤 다시 측정. 의식이 흐리면 먹이지 말고 119.

URGENT · 02

심한 고혈당 · 의식 변화



구토·복통·가쁜 숨·의식 변화가 있으면 혈당과 관계없이 즉시 응급실. 증상 없이 혈당만 높게(300 이상) 지속돼도 빨리 연락하세요.

WATCH · 03

갑작스러운 시력 변화



물체가 일그러지거나 검은 점·시야 가림 — 눈 속 출혈이 의심되니 빠른 안과 평가가 필요합니다.

WATCH · 04

발 상처가 안 나옴



상처가 2주 이상 지속되거나 붓고 열나고 냄새 — 당뇨발 진행, 빨리 보여 주세요.

WATCH · 05

가슴 답답함 · 호흡곤란



활동 시 가슴 압박감·식은땀 — 당뇨는 무증상 심근경색이 흔해 늦지 않게 평가합니다.

WATCH · 06

부종 · 거품뇨 · 소변량 감소



다리 부종·거품뇨 — 콩팥 합병증 신호. uACR·eGFR를 다시 확인합니다.

첫 외래 후 실천 7가지

오늘 집에 가서 시작할 일입니다. 완벽하지 않아도 됩니다 — 꾸준함이 곧 치료입니다

01

약 매일 같은 시간 — 메트포민은 식사와 함께. 임의 중단 금지, 불편하면 알려주기.

02

혈당 자가측정 + 기록 — 공복·식후 2시간 번갈아, 진료 때 함께 검토.

03

접시법 + 식후 10분 걷기 — 가장 쉬운 두 가지부터 습관으로.

04

매일 발 살피기 — 상처·물집·색 변화 확인. 맨발·뜨거운 물 주의.

05

HbA1c 3개월 뒤 재검 — 첫 목표 달성 여부를 함께 확인하고 조정.

06

금연·절주 + 예방접종 — 합병증을 줄이는 가장 확실한 투자.

07

다음 예약 지키기 — 공금증·부작용은 메모해 오면 진료가 빨라집니다.

진단은 끝이 아니라 시작입니다 — 함께 가면 됩니다

궁금한 점은 언제든지 물어보세요. 첫 1~2년의 관리가 평생 합병증 위험을 결정합니다

광교바른내과 진료 안내

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층

☎ 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진



다시 보기 · 카톡 공유